



国家知识产权局

100034

北京市西城区平安里西大街 28 号楼 15 层 1501-02 号房间
北京瑞恒信达知识产权代理事务所（普通合伙） 曹津燕, 张伟
(010-62133181/13701319396)

发文日：

申请号或专利号：200480011401.1

发文序号：

案件编号： 4W113992

发明创造名称： 治疗白介素-6 相关疾病的方法

专利权人： 中外制药株式会社

无效宣告请求人： 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

无 效 宣 告 请 求 审 查 决 定 书

(第 560509 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐ 宣告专利权全部无效。

☒ 宣告专利权部分无效。

☐ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 19 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：王亦然

主审员：魏聪

参审员：吴文英

专利局复审和无效审理部

201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 560509 号)

案件编号	第 4W113992 号
决定日	2023 年 03 月 24 日
发明创造名称	治疗白介素-6 相关疾病的方法
国际分类号	A61K 39/395
无效宣告请求人	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
专利权人	中外制药株式会社
专利号	200480011401.1
申请日	2004 年 04 月 28 日
优先权日	2003 年 04 月 28 日
授权公告日	2011 年 06 月 15 日
无效宣告请求日	2022 年 03 月 04 日
法律依据	专利法第 22 条第 2、3 款、第 26 条第 3、4 款；专利法实施细则第 13 条第 1 款、第 20 条第 1 款
决定要点： 涉及“药物联用”的特征对于物质的医药用途权利要求是否具备限定作用以及如何理解此类型权利要求的保护范围，关键在于研判该特征能否实际影响制药过程，即能否有效地限定药品的原料及制备工艺。在包含两种或者多种药物联用特征的医药用途权利要求中，如果这些药物具有不同的给药方式，则应当认定该权利要求实质上保护包含两种或者多种药物的药包产品的制药用途发明，其中所述药物分别采用与其给药方式相适应的剂型。 在发明新颖性的评判中，需要从技术领域、技术方案、解决的技术问题及相应的技术效果这四方面判断发明的技术方案与现有技术是否实质相同。就物质的医药用途发明而言，在发明充分证实了该医药用途的前提下，如果现有技术中缺乏确切实验结果证实，仅依据理论推测而提及所述物质能够治疗该发明中所述的疾病，则这样的信息通常不足以反映该物质能够有效治疗所述疾病患者的确切结论，不应当视为该医药用途已被现有技术公开。 在确定现有技术是否给出了获得发明技术方案的技术启示时，应当考察在未得知发明技术方案的前提下，所属领域技术人员仅基于现有技术的教导是否有动机改进现有技术以获得发明的技术方案，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑基于现有技术进行这种改进的可能性或	

者可行性。就物质的医药用途发明而言，该物质作为已知的药物活性成分，其药理、药化等方面的研究通常较为充分，相关现有技术的信息往往汗牛充栋，在判断能否由此显而易见地得到该物质的新医药用途时，应当基于所属领域技术人员的合理认知，客观认定发明因其技术方案的选择所实现的技术效果，由此确定其实际解决的技术问题，然后对现有技术进行整体梳理，以便准确还原获得发明的过程。

任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法或者专利法实施细则有关禁止重复授权的规定而请求国家知识产权局宣告其中授权在前的专利权无效的，在其他无效理由不成立的情况下，国家知识产权局应当维持该项专利权有效。

一、案由

本专利的专利号为 200480011401.1，优先权日为 2003 年 04 月 28 日，申请日为 2004 年 04 月 28 日，授权公告日为 2011 年 06 月 15 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 治疗类风湿性关节炎的药物组合物，包含 MRA 和氨甲蝶呤。

2. 权利要求 1 的药物组合物，其中 MRA 的剂量为 0.02-150mg/kg/4 周或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量。

3. 权利要求 2 的药物组合物，其中 MRA 的剂量为 0.5-30mg/kg/4 周或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量。

4. 权利要求 3 的药物组合物，其中 MRA 剂量为 2-8mg/kg/4 周或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量。

5. 权利要求 1 的药物组合物，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 1-100mg/个体/周。

6. 权利要求 5 的药物组合物，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 4-50mg/个体/周。

7. 权利要求 6 的药物组合物，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 7.5-25mg/个体/周。

8. 权利要求 1-7 任一项的药物组合物，其制备为用于将 MRA 和氨甲蝶呤同时施用的制剂。

9. 权利要求 1-7 任一项的药物组合物，其制备为用于将 MRA 和氨甲蝶呤在时间上间隔施用的制剂。

10. MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物中的用途。

11. 权利要求 10 的用途，其中 MRA 剂量是 0.02-150mg/kg/4 周或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量。

12. 权利要求 30 的用途，其中 MRA 剂量是 0.5-30mg/kg/4 周或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量。

13. 权利要求 31 的用途，其中 MRA 剂量是 2-8mg/kg/4 周或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量。

14. 权利要求 10 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 1-100mg/个体/周。

15. 权利要求 14 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 4-50mg/个体/周。

16. 权利要求 15 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 7.5-25mg/个体/周。

17. 权利要求 10-16 任一项的用途，用于将 MRA 和氨甲蝶呤同时施用。

18. 权利要求 10-16 任一项的用途，用于将 MRA 和氨甲蝶呤在时间上间隔施用。”

请求人于 2022 年 03 月 04 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是：针对权利要求 1-18 保护的技术方案，说明书充分不公开，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-18 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 2-9、11-18 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；权利要求 1-18 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定；权利要求 1-18 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-18 无效，同时提交了如下证据：

证据 1：西本憲弘，治療学，2002 年第 36 卷第 12 期，第 1264-1267 页，及其部分中文译文；

证据 2：Joel M. Kremer 等，ALONG-TERM PROSPECTIVE STUDY OF THE USE OF METHOTREXATE IN RHEUMATOID ARTHRITIS, Arthritis & Rheumatism, 1988 年第 31 卷第 5 期，第 577-584 页，及其部分中文译文；

证据 3: E. H. S. Choy 等, Therapeutic Benefit of Blocking Interleukin-6 Activity With an Anti - Interleukin-6 Receptor Monoclonal Antibody in Rheumatoid Arthritis, A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Escalation Trial, ARTHRITIS & RHEUMATISM, 2002 年第 46 卷第 12 期, 第 3143-3150 页, 及其部分中文译文;

证据 4: RAFAEL SEGAL 等, RESCUE OF INTERLEUKIN-1 ACTIVITY BY LEUCOVORIN FOLLOWING INHIBITION BY METHOTREXATE IN A MURINE IN VITRO SYSTEM, Arthritis and Rheumatism, 第 33 卷第 11 期, 1990 年 11 月, 第 1745-1748 页, 及其部分中文译文。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2022 年 03 月 15 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人, 同时成立合议组对本案进行审查。

请求人又于 2022 年 04 月 02 日提交了无效宣告请求补充意见, 同时提交了证据 1-4 及其部分中文译文以及如下证据的复印件(编号续前):

证据 5: 本专利的中国分案申请 ZL201511004468.9 授权公告文本。

请求人主张: (1) 实施例 1 中采用了何种 MRA 安慰剂、氨甲蝶呤(MTX)安慰剂以及 MTX 和 MTX 安慰剂各自每一次的具体给药量的信息缺失, 也没有证明 MRA 和 MTX 在类风湿性关节炎的治疗中具有协同作用, 所公开的信息只能证明有效或安全, 不能证明协同或改进效果, 因此本专利不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

(2) 权利要求 2-9、11-18 没有说明发明的技术特征, 没有清楚、简要地表述保护的范围, 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。(3) 权利要求 1-9 实际的保护范围为一种用于治疗类风湿性关节炎的包含 MRA 和 MTX 的药物组合物, 权利要求 10-18 实际的保护范围为 MRA 和 MTX 用于制备类风湿性关节炎治疗药物的用途, 基于前述说明书公开不充分的理由, 以上权利要求得不到说明书的支持; 同时, 本领域技术人员基于本专利说明书提供的实验数据, 无法确定 MRA 和氨甲蝶呤或进一步地在任何浓度或含量下的 MRA 和 MTX 能够在类风湿性关节炎的治疗中发挥协同作用, 导致权利要求 1-18 的保护范围得不到说明书的支持。(4) 权利要求 1-18 相对于证据 1 不具备新颖性。(5) 权利要求 1-18 相对于证据 1 和常规技术手段的结合、证据 1 和证据 2 以及常规技术手段的结合、证据 3 和证据 2 的结合、证据 3 和证据 4 的结合均不具备创造性。(6) 权利要求 1-9、10-18 分别与证据 5 的权利要求 1、7 保护范围相同, 构成重复授权, 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

本案合议组于 2022 年 04 月 13 日将请求人提交的上述无效宣告请求补充意见及其证据转送给专利权人。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 04 月 22 日提交了意见陈述书, 并表示不认可请求人的上述无效理由及证据译文; 又于 2022 年 05 月 30 日提交了意见陈述书, 同时提交了如下反证的复印件以及证据 1-4 的译文更正页:

反证 1: 于中兴主编, 中国药政辞典, 中国医药科技出版社, 1994 年 3 月第一版第一次印刷, 封面页、书名页、出版信息页、编者页、前言页、目录页、第 17-19 页;

反证 2: Rheumatrex®标签及其中文译文;

反证 3: Not Yet Time to Change the Guidelines for Monitoring Methotrexate Liver Toxicity: They Have Served Us Well, The Journal of Rheumatology, 2002 年第 29 卷第 8 期, 第 1590-1592 页, 及其中文译文;

反证 4: ROBERT F. WILLKENS 等, COMPARISON OF AZATHIOPRINE, METHOTREXATE, AND THE COMBINATION OF THE TWO IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS, Arthritis & Rheumatism, 第 38 卷第 12 期, 1995 年 12 月, 第 1799-1806 页, 及其部分中文译文;

反证 5: H. JAMES WILLIAMS 等, COMPARISON OF AURANOFIN, METHOTREXATE, AND THE COMBINATION OF BOTH IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS, Arthritis & Rheumatism, 第 35 卷第 3 期, 1992 年 03 月, 第 259-269 页, 及其部分中文译文;

反证 6: David T. Felson 等, The Efficacy and Toxicity of Combination Therapy in Rheumatoid Arthritis, Arthritis & Rheumatism, 第 37 卷第 10 期, 1994 年 10 月, 第 1487-1491 页, 及其部分中文译文;

反证 7: Osamu Okuda, Anti IL-6 Receptor Antibody, MRA, 第 1-30 页, 及其部分中文译文, 2003 年 01 月 23 日;

反证 8: Serious liver disease in a patient receiving methotrexate and leflunomide, Arthritis & Rheumatism, 第 43 卷第 11 期, 2000 年 11 月, 第 2609-2613 页, 及其部分中文译文。

专利权人认为: (1) 基于反证 1, 本领域技术人员能够理解安慰剂的含义及其给药方案。(2) 本专利实施例 1 记载了药物组合的有效性增强, 过敏反应减少, 并且具有可接受的肝毒性。(3) 权利要求范围应根据“全面覆盖原则”进行解释, 即所有特征均可用于定义权利要求的范围, 因此从属权利要求保护的范围与其引用的独立权利要求不同, 本专利权利要求保护的范围与其分案也不同。(4) 证据 1、3 均未公开 MRA 和氨甲蝶呤联合治疗的技术效果, 更未公开该联合治疗是有效的, 其它证据也未给出明确教导; 另外, 反证 2 和 3 表明氨甲蝶呤随着剂量增加而毒性增加, 反证 4-6 表明两种或多种 DMARDs 治疗类风湿性关节炎并不比单一药物治疗更有效, 甚至具有更高的毒性, 反证 2、3、7 和 8 表明氨甲蝶呤或 MRA 具有肝毒性; 因此本专利具备新颖性和创造性。

同时, 专利权人修改了权利要求书, 其中删除了原权利要求 1-9; 将权利要求 10、12 和 13 中的“药物组合物”、“权利要求 30 的用途”、“权利要求 31 的用途”分别改为“药物组合物”、“权利要求 2 的用途”和“权利要求 3 的用途”; 并且相应地调整了各权利要求的编号和引用关系。修改后的权利要求书为:

“1. MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物中的用途。

2. 权利要求 1 的用途, 其中 MRA 剂量是 0.02-150mg/kg/4 周或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量。

3. 权利要求 2 的用途, 其中 MRA 剂量是 0.5-30mg/kg/4 周或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量。

4. 权利要求 3 的用途，其中 MRA 剂量是 2-8mg/kg/4 周或显示出与其等同的血液 MRA 浓度的剂量。
5. 权利要求 1 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 1-100mg/个体/周。
6. 权利要求 5 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 4-50mg/个体/周。
7. 权利要求 6 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 7.5-25mg/个体/周。
8. 权利要求 1-7 任一项的用途，用于将 MRA 和氨甲蝶呤同时施用。
9. 权利要求 1-7 任一项的用途，用于将 MRA 和氨甲蝶呤在时间上间隔施用。”

本案合议组分别于 2022 年 05 月 31 日、06 月 06 日将专利权人上述两次提交的意见陈述书及其附件转送给请求人；又于 2022 年 06 月 07 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2022 年 07 月 25 日举行口头审理。

口头审理如期举行，请求人委托的北京瑞恒信达知识产权代理事务所专利代理师曹津燕、张伟，专利权人委托的北京市奋迅律师事务所专利代理师李斌馨、袁伟出席了本次口头审理，双方当事人对对方出庭人员的身份和资格均无异议，对合议组成员无回避请求。本案合议组对本无效宣告请求的无效理由和证据逐一进行了调查，双方当事人均充分陈述了意见。

在口头审理过程中，专利权人当庭提交了权利要求书的全文替换页（共 1 页 9 项），在 2022 年 04 月 06 日提交的权利要求书的基础上，进一步删除了权利要求 2-4 中的“或显示出与其等同的血液 MRA 浓度的剂量”，修改后的权利要求书为：

- “1. MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物中的用途。
2. 权利要求 1 的用途，其中 MRA 剂量是 0.02-150mg/kg/4 周。
 3. 权利要求 2 的用途，其中 MRA 剂量是 0.5-30mg/kg/4 周。
 4. 权利要求 3 的用途，其中 MRA 剂量是 2-8mg/kg/4 周。
 5. 权利要求 1 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 1-100mg/个体/周。
 6. 权利要求 5 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 4-50mg/个体/周。
 7. 权利要求 6 的用途，其中所述氨甲蝶呤的剂量是 7.5-25mg/个体/周。
 8. 权利要求 1-7 任一项的用途，用于将 MRA 和氨甲蝶呤同时施用。
 9. 权利要求 1-7 任一项的用途，用于将 MRA 和氨甲蝶呤在时间上间隔施用。”

请求人对于无效宣告程序中权利要求书的修改没有异议，明确无效理由为：本专利说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-9 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；权利要求 1-9 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-9 相对于证据 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性；权利要求 1-9 相对于证据 1 和常规技术手段的结合、证据 1 和证据 2 以及常规技术手段的结合、证据 3 和证据 2 的结合、证据 3 和证据 4 的结合均不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性；权利要求 1-9 与证据 5 的权利要求 7 保护范围相同，构成重复授权，不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的

规定，当庭提交了证据 1 的公证书原件（即，北京市长安公证处作出的（2022）京求是内经证字第 794-797 号公证书），专利权人认可证据 1-5 的真实性、合法性、公开性和公开时间，主张请求人提供的证据 1-4 中文译文不全，以全文翻译文本更有助于理解其内容。请求人同意以专利权人提交的证据 1-4 全文译文为准，认可反证 1、3-6、8 的真实性，不认可反证 2 的公开时间和反证 7 的真实性、关联性及公开时间。

针对本案权利要求的保护范围，请求人强调，用药特征对于医药用途权利要求没有限定作用，该类型权利要求需要对应于具有固定形态的产品，否则就不应当得到专利保护；专利权人强调，根据说明书的记载，本专利的药物组合物包括在同一剂型中或者不在同一剂型中的各种情形。

针对新颖性，专利权人强调，证据 1 未构成完整的技术方案，也没有公开相应的适应症，因此不影响本专利新颖性。

针对本发明的技术效果，请求人强调，本专利说明书探讨的是 MRA 单独治疗类风湿性关节炎的疗效，无法获得 MRA 和氨甲蝶呤协同增效的信息。专利权人则主张，MRA 和氨甲蝶呤的组合相对于单药具有统计学优势，副作用的记载也佐证了协同增效的效果。

双方当事人分别于 2022 年 08 月 15 日和 29 日提交了口头审理代理词，重申了口头审理中陈述的意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

（一）法律适用

本专利的优先权日为 2003 年 04 月 28 日，均早于 2009 年 10 月 01 日，根据“施行修改后的专利法的过渡办法”和“施行修改后的专利法实施细则的过渡办法”的规定，针对本专利的无效宣告请求的审理应适用 2000 年 08 月 25 日第二次修正的中华人民共和国专利法及 2001 年 06 月 15 日修订的中华人民共和国专利法实施细则。

（二）审查基础

专利权人于 2022 年 07 月 25 日提交了权利要求书的修改替换页（共 9 项），相对于授权公告文本而言，所作修改在于删除了权利要求 1-9，删除了权利要求 11-13 中的“或显示出与其等同的血液 MRA 浓度的剂量”这一并列技术方案，将权利要求 10、12 和 13 中的“药物细合物”、“权利要求 30 的用途”、“权利要求 31 的用途”分别修改为“药物组合物”、“权利要求 2 的用途”和“权利要求 3 的用途”，同时相应地调整了各权利要求的编号和引用关系。请求人对上述修改方式及其修改时机均无异议。

合议组经审查后认为：首先，授权文本中的独立权利要求 10 保护“MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物细合物中的用途”，而相关的产品权利要求 1 保护“治疗类风湿性关节炎的药物组合物，包含 MRA 和氨甲蝶呤”，本领域技术人员据此可以理解前述权利要求 10 中的“药物细合物”属于明显笔误，应为“药物组合物”；其次，授权文本中的从属权利要求 12、13 分别位于从属权利要求 11 之后，分别保护

“权利要求 30 的用途”和“权利要求 31 的用途”，并且均进一步限定了其中 MRA 的剂量范围，而授权文本中并不存在权利要求 30 和 31，相应的从属权利要求 11、14-16 均引用了前述独立权利要求 10，并且分别以权利要求 10 及其从属权利要求为基础进一步层层限定了其中 MRA 和氨甲蝶呤的剂量范围，本领域技术人员据此可以明确前述权利要求 12、13 的引用关系属于明显笔误，均应当以前述独立权利要求 10（对应于修改后的权利要求 1）及其相应的从属权利要求为引用基础，这也与本领域中常见的剂量范围限缩的权利要求撰写形式一致；再次，删除授权公告文本中的权利要求 1-9 的修改方式属于权利要求的删除，删除授权公告文本中的权利要求 11-13 中“或显示出与其等同的血液 MRA 浓度的剂量”的修改方式属于技术方案的删除，以上修改也均得到请求人的认可。综上，合议组确认专利权人对权利要求书的上述修改符合《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6 节中关于无效宣告程序中专利文件修改的相关规定。

因此，本决定以专利权人于 2022 年 07 月 25 日提交的权利要求第 1-9 项，以及本专利授权公告文本中的其它部分作为审查基础。

（三）关于证据

证据 1-4 是外文期刊，专利权人认可以上证据的真实性、合法性、公开性和公开时间，对此合议组予以确认；专利权人还主张请求人提供的证据 1-4 部分中文译文内容不全，以全文翻译文本更有助于理解其内容，请求人同意以专利权人提交的证据 1-4 全文译文为准，合议组确认在专利权人提交的证据 1-4 中文译文基础上进行审理。证据 5 是专利文献，专利权人认可其真实性，属于本案的分案专利授权公告文本，对此合议组予以确认。

反证 1 是本领域工具书，反证 3-6、8 属于国外期刊文献，请求人认可上述反证的真实性、合法性、公开性、公开时间，认可反证 3-6、8 的译文准确性，合议组对此予以确认。

反证 2 是关于药品信息的英文打印件及其部分中文译文，专利权人主张其是药品说明书，并且提供了获得方式的时间戳文件，用于证明现有技术中已知氨甲蝶呤具有肝毒性，请求人不认可其公开时间，合议组经审核认可该反证的真实性和公开性，但是鉴于专利权人并未提供证明其公开时间的证据，无法确认该反证的公开时间，更无法确认该反证是否属于本专利的现有技术文献。

反证 7 是关于 MRA 信息的英文 PPT 打印件及其部分中文译文，专利权人主张该反证来自国外网站，但是并未提供证明其真实性的任何证据，请求人不认可该反证的真实性、关联性及公开时间，合议组认为：反证 7 属于域外证据，《专利审查指南》对于域外证据给出的定义是在中华人民共和国领域外形成的证据，同时规定该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续，其中还规定了例外情形，即“如果该证据能够从除香港特区、澳门特区、台湾地区外的国内公共渠道获得、有其他证据足以证明该证据真实性或者对方当事人认可该证据的真实性的，当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续”。据此可知，对于域外证据，

除非属于上述例外的情形（例如，从专利局获得的国外专利文件或者从公共图书馆获得的国外文献资料等无需办理相关的证明手续），当事人均应当履行比如公证认证等相关证明手续，尤其是在对方当事人对其真实性提出有效质疑的情况下更需要履行证明手续。而本案中，请求人并未针对该域外证据履行相关的证明手续，因此无法确认其真实性。

（四）关于医药用途权利要求保护范围的理解

根据中国专利法第 25 条第 1 款第（三）项的规定，疾病的诊断和治疗方法是不授予专利权的客体。在中国专利审查实践中，为了避免与上述条款造成冲突，药品用途发明通常以制药用途形式的权利要求得以保护，即以“物质 X 在制备治疗（诊断）Y 疾病的药物中的用途”或者与此相类似的形式出现（参见《专利审查指南》第二部分第十章第 4.5.2 节），这类权利要求通常具有三个主要技术特征：物质 X；物质 X 制备成药物；治疗 Y 疾病。

物质的制药用途发明属于方法发明，其权利要求属于方法类型，应从方法权利要求的角度来分析其技术特征。通常能直接起到限定作用的是原料、制备步骤和工艺条件、药物产品形态或成分以及设备等。对于仅涉及药物使用方法的特征，如果这些特征与制药方法之间并不存在直接关联，其实质上属于在实施制药方法并获得药物后，将药物施用于人体的具体用药方法，与制药方法没有直接、必然的关联性。这种仅体现于用药行为中的特征不是制药用途的技术特征，对权利要求保护的制药方法本身不具有限定作用。

近年来，随着制药行业的快速发展，尤其随着针对慢性疾病以及精准医疗的研发日渐深入，物质的制药用途发明创造中越来越多地包含了药品剂量、给药时间、给药频次、特定给药方式以及特定给药对象等相关的技术改进。这些改进往往与药品的原料或制备工艺并不相关，而与药品的使用密切相关，因此体现这些改进的特征通常并不属于医药用途权利要求中的技术特征，对权利要求保护的制药方法本身也不具有限定作用。

有一类非常特殊的所谓“药物联用”的发明创造类型，即权利要求以“物质 X_1 、 X_2 ……和 X_n 在制备治疗（诊断）Y 疾病的药物中的用途”或者与此相类似的形式出现，同时由于此类型的发明通常可以通过将联用的两种或者多种药物制备成为复方制剂、或联合使用各药物活性组分的试剂盒等形式，将技术方案中涉及“药物联用”的特征真切地落实于药品的原料及制备工艺中，在此情形下就应当认定涉及“药物联用”的特征对于权利要求保护的制药方法本身具有实质的限定作用。可见，确定该类型特征是否具备限定作用以及如何理解此类型权利要求保护范围，关键在于研判权利要求技术方案中涉及“药物联用”的特征能否实际影响制药过程，即能否有效地限定药品的原料及制备工艺。

本案中，权利要求 1 保护 MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物中的用途。根据说明书的记载，本发明提供了治疗白介素-6（IL-6）相关疾病的药物组合物，包括 IL-6 拮抗剂和免疫抑制剂，其中白介素-6 相关疾病的代表即为类风湿性关节炎，IL-6 拮抗剂优选托珠单抗（MRA），MRA 是重组人源化

的 IgG1 亚类抗人白介素-6 受体的单克隆抗体，可以抑制 IL-6 的功能，免疫抑制剂优选氨甲蝶呤（MTX），以上两种活性成分既可以同时给药，也可以间隔一段时间给药；进一步来说，在具体实施方式中 MRA 通过静脉输注以 4 周为间隔给药，氨甲蝶呤通过口服每周一次给药（参见本专利说明书第 0011-0030、0145-0150 段）。另外，本专利说明书还明确提到本发明是针对“还不知道抗 IL-6R 抗体与免疫抑制剂，例如氨甲蝶呤（MTX）组合在治疗 IL-6 相关疾病中可获得协同作用”的现有技术状况进行的改进，在具体实施例中验证了 MRA 和氨甲蝶呤组合治疗的疗效明显优于 MRA 单独治疗以及氨甲蝶呤单独治疗的疗效（参见本专利说明书第 0010、0146-0177 段）。如前所述，在口头审理中专利权人亦确认 MRA 通常通过静脉输注及皮下注射给药，但是不会采用口服给药的方式，而氨甲蝶呤通常通过口服给药，同时也不排除肌肉注射和皮下注射等常规给药方式，且两者的给药间隔通常也有不同，可见一般来说这两种药品在给药方式和给药频次上均存在明显差异。

基于以上案件事实，本领域技术人员根据抗体药 MRA 和化学药氨甲蝶呤各自的性质特点和常规给药方式，结合说明书公开的整体发明构思的信息，足以判断本案权利要求 1 保护的技术方案中 MRA 和氨甲蝶呤不适于制备成复方制剂，但是尚可以选择制备成这两种药品联合使用的药包产品。也就是说，权利要求 1 中的“药物组合物”应当理解为一种包括所述两种药品的药包产品，而不应理解为仅在连续给药过程中分别使用这两种药品的治疗方案，因为前者将联合用药的特征落实于药品的原料及制备工艺中，属于物质的医药用途发明，能够得到专利法的保护，而后者仅与药品的使用密切相关，而与药品的原料或制备工艺并不相关，本质上属于疾病的治疗方法，不在专利法保护的范畴之内。由此可见，作为已经获得授权的发明技术方案，权利要求 1 的保护对象应当相应地界定为 MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药包产品中的用途。

（五）关于说明书是否公开充分以及权利要求能否得到说明书的支持

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

如果本领域技术人员根据说明书的记载，能够实现说明书中所述的技术方案，解决其技术问题，并且能够产生预期的技术效果，那么本专利说明书是公开充分的，保护相应技术方案的权利要求能够得到说明书的支持。

本案中，无效请求人主张：本专利说明书的内容旨在验证 MRA 治疗类风湿性关节炎的有效性和安全性，而非证明联合用药的优良技术效果，具体实施方式中关于安慰剂种类和剂量的信息缺失，且本专利实验数据中联用的 ACR 值劣于或者略优于单独给药 ACR 值的简单加和，不良反应的实验结果仅能说明安全有效性，不能证明效果的改善，更不能证明联合用药的协同作用，导致说明书没有充分公开发明的技术方案，相应的权利要求得不到说明书的支持。专利权人则强调，反证 1 公开了安慰剂的定义，本领域技术人员能够理解其含

义，并且实施相应的具体实施方式；本专利说明书证实了 MRA 和氨甲蝶呤联用的有效性增强且过敏反应减少、肝毒性可接受。

对此，合议组认为：首先，本专利说明书在具体实施方式中将 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗，与 MRA 单独治疗、氨甲蝶呤单独治疗的效果进行比较，其中采用安慰剂分别代替 MRA、氨甲蝶呤以便测定单药的疗效和安全性（参见本专利说明书第 0146-0177 段）。本领域公知，安慰剂是指药物临床试验对照组病人服用无明显病理作用的物质，不论在数量上或者外表上均应和治疗剂尽可能一致，比如它们的包装、色泽、气味等（参见，例如：反证 1）。由此，本领域技术人员能够理解该术语的准确含义，并且根据技术常识选择合适的安慰剂种类，并且采用与治疗剂相同的剂型、外观、重量、给药方式及给药间隔等参数，从而有效实施本专利说明书公开的具体实施方式，并且验证其相应的技术效果。也就是说，说明书中没有具体公开安慰剂种类及剂量等信息的事实不会导致说明书公开不充分。

其次，本专利说明书在发明概述部分明确记载了“本发明提供了治疗白介素-6（IL-6）相关疾病的药物组合物，包括 IL-6 拮抗剂和免疫抑制剂”，其中白介素-6 相关疾病的代表即为类风湿性关节炎，IL-6 拮抗剂优选托珠单抗（MRA），免疫抑制剂优选氨甲蝶呤（MTX）；进一步在具体实施方式中将 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗，与 MRA 单独治疗、氨甲蝶呤单独治疗的效果进行比较，尽管在疗效对比中没有直接论述组合治疗的好处，但是数据已经体现出这样的优势（例如，本专利说明书第 15-16 页表 1 公开了在三个剂量组中组合治疗相比于 MRA 单独治疗的各项患者改善评分均有明显提升，同时在 8mg/kg 剂量组中组合治疗相比于氨甲蝶呤单独治疗的各项患者改善评分也有明显提升），同时在安全性对比中多次验证了组合治疗在过敏性、抗体产生、肝毒性等方面的改善（例如，“所有这些过敏事件都发生在不与 MTX 组合的情况下第 3 次或第 4 次 MRA 给药后”，即所有组合治疗实验均未出现过敏情况；组合治疗组或者“没有抗体产生”，或者“比 MRA 单独治疗组出现较少的抗体产生事件”；肝功相关指标的提升“与在其它类风湿性关节炎患者中观察到的相当”，即具有可接受的肝毒性，参见本专利说明书第 0168-0175 段）。即使 2mg/kg、4mg/kg 剂量组中组合治疗在个别的改善评分（ACR 70）上略低于氨甲蝶呤单独治疗的评分，也并不意味着这样的组合治疗效果变劣，相反，考虑到前述两个剂量组中组合治疗在其他改善评分（ACR 20、ACR 50）上均明显高于氨甲蝶呤单独治疗的评分，可知其在肿胀关节数、疼痛关节数等多项指标改善 20% 以上及 50% 以上的患者数均明显高于单独治疗的改善患者数，这足以证明组合疗法在改善类风湿性关节炎患者的症状上具备明显的优势，ACR 70 评分上的差距仅涉及改善的症状在种类广泛性上的不同，并不代表在主要症状（例如，ACR 20、ACR 50）的改善上有所欠缺，况且在本领域公知大剂量使用氨甲蝶呤存在严重副作用的前提下，证实抗体与之联合治疗的有效性与安全性的发明也是有其现实价值的。

再次，请求人主张的“单独给药 ACR 值的简单加和”计算方式缺乏科学依据，且 MRA 与氨甲蝶呤是否具备协同作用也与说明书是否充分公开发明的技术方案没有直接关联。

可见，本领域技术人员基于说明书的记载以及本领域公知常识，可以预期权利要求所述 MRA 和氨甲蝶呤

制备的药包产品在治疗类风湿性关节炎上的疗效和安全性，权利要求的技术方案能够得到说明书的支持。无效请求人所主张的上述无效理由均不足以导致本专利不符合专利法第 26 条第 3、4 款的规定，合议组对上述无效理由不予支持。

（六）关于医药用途权利要求的新颖性

专利法第 22 条第 2 款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

在发明新颖性的评判中，需要从技术领域、技术问题、技术方案及相应的技术效果这四方面判断发明的技术方案与现有技术是否实质相同。就物质的医药用途发明而言，在发明充分证实了该医药用途的前提下，如果现有技术中缺乏确切实验结果证实，仅依据理论推测而提及所述物质能够治疗该发明中所述的疾病，则这样的信息通常不足以反映该物质能够有效治疗所述疾病患者的确切结论，不应当视为该医药用途已被现有技术公开。也就是说，如果无法确认现有技术能够有效治疗该发明中所述的疾病并且取得预期的疗效和足够的安全性的话，就不能仅依据技术方案表述上的一致性而认定该医药用途发明不具备新颖性。

请求人主张本专利权利要求 1-9 相对于证据 1 均不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

对此，合议组认为：证据 1 是一篇期刊综述文章，公开了以 MRA 为代表的抗 IL-6 受体抗体对于类风湿性关节炎的治疗作用，具体来说，在分析 IL-6 类风湿性关节炎的发病机制中的作用得出“阻断 IL-6 的作用可能为类风湿性关节炎提供一种新的治疗方法”结论的基础上，提到在日本开发出一种人源化抗 IL-6 受体抗体，该抗体是单克隆抗体，可以特异性地阻断 IL-6 的作用，被称为骨髓瘤受体抗体（MRA）。该抗体针对风湿性关节炎和类风湿性关节炎的疗效研究经历了如下历程：在大阪大学使用 MRA 治疗难治性风湿病患者，不仅使“炎症标志物显著正常化”，而且“迅速改善关节症状和一般症状”；在此基础上，对风湿病患者进行了 I 期临床研究，其中 5mg/kg 剂量组“观察到疗效”，而“在任何其他剂量组都没有获得明显的治疗效果”；同时启动了针对类风湿性关节炎患者的 I/II 期研究，证实了“良好的疗效”，没有观察到“严重的不良事件”；根据研究结果，进行了晚期 II 期研究，并且根据研究结果给出了建议的治疗方案：“此外，目前在几个欧洲国家正在进行一项与甲氨蝶呤（注：即氨甲蝶呤，下同）联合用药的 II 期研究”。

关于该抗体的安全性，文章对比了现有技术中常用于治疗类风湿性关节炎的英夫利西单抗，提到“在用英夫利西单抗治疗时，需要联合使用甲氨蝶呤来抑制自身抗体的出现，并限制对嵌合抗体的中和抗体的出现。然而，MRA 并不要求联合使用甲氨蝶呤”。

文章结尾还明确了下一步的研究方向，即“今后，在确定长期治疗效果的同时，还应该进行研究，调查各种抗细胞因子治疗的区分使用或其联合应用的治疗效果”（参见该证据中文译文第 2 页第 10-16 行、第 3

页第 3-24 行、第 4 页第 5-8、19-20 行）。

请求人认为：基于证据 1 中“目前在几个欧洲国家正在进行一项与甲氨蝶呤联合用药的 II 期研究”的内容，该证据已经公开了 MRA 和氨甲蝶呤联合用于治疗类风湿性关节炎的技术方案，导致本专利权利要求 1 不具备新颖性。专利权人则强调，依据第 27371、54130 号无效宣告请求审查决定的观点，因为证据 1 未公开有效治疗的结果，应当认可本专利的新颖性。

对此，合议组认为：在发明新颖性的评判中，需要从技术领域、技术问题、技术方案及相应的技术效果这四方面判断发明的技术方案与现有技术是否实质相同。

就本案技术效果的对比来看，本发明提供了 MRA 和氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的 II 期临床研究和结果，具体来说，针对已用氨甲蝶呤治疗过规定的一段时期的活性类风湿性关节炎患者作为实验对象，采用 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗，与 MRA 单独治疗、氨甲蝶呤单独治疗的效果进行比较，结果发现在完成研究的 299 位患者中 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗（以下简称 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 联用）的效果在整体上均明显优于相应的 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 给药剂量的 MRA 单独治疗（以下简称 2mg/kg、4mg/kg 及 8mg/kg 单独使用）和氨甲蝶呤单独治疗的效果；同时，MRA 与氨甲蝶呤组合治疗的病例均未发生过敏事件，且 8mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗组未产生抗 MRA 抗体，2mg/kg、4mg/kg 给药剂量的 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗组也“比 MRA 单独治疗组出现较少的抗体发生事件”，证实了 MRA 与氨甲蝶呤组合治疗的安全性（参见本专利说明书第 0146-0177 段）。

相应的，如前面引用的证据 1 相关内容，可知该证据的主旨在于综述 MRA 用于治疗类风湿性关节炎的研究进展，其中提到“目前在几个欧洲国家正在进行一项与甲氨蝶呤联合用药的 II 期研究”的信息只是在前述 MRA 单独用于治疗类风湿性关节炎的临床试验研究基础上补充的客观事实，并未公开上述 II 期临床研究的结论，更未公开该研究的任何临床数据。本领域公知 II 期临床研究是治疗作用初步评价阶段，目的在于初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也就是说在 II 期临床以及随后进一步研究的结果没有公开的前提下，本领域技术人员无法确认该联合用药的疗效和安全性。与之相反，该证据一方面在安全性分析中强调并不需要通过联合使用 MRA 与氨甲蝶呤的方式以降低副作用，另一方面在展望未来研究方向时也承认联合疗法的治疗效果尚需进一步研究。由此本领域技术人员亦无法认识到该证据推荐 MRA 与氨甲蝶呤联合治疗类风湿性关节炎，无法获得 MRA 与氨甲蝶呤能够有效联合治疗类风湿性关节炎患者的确切结论。

可见，尽管本专利权利要求 1 的医药用途发明与证据 1 在表述上存在一致性，但是基于技术效果的对比，本专利充分证实了 MRA 与氨甲蝶呤能够有效联合治疗类风湿性关节炎患者，而依据证据 1 尚无法得出有效治疗的确切结论，由此不能仅依据技术方案表述上的一致性而认定本发明不具备新颖性。权利要求 1 相对于证据 1 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。从属权利要求 2-9 直接或者间接引用了权利要求 1，相对于证据 1 也具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

（七）关于医药用途权利要求的创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

在确定现有技术是否给出了获得发明技术方案的技术启示时，应当考察在未得知发明技术方案的前提下，所属领域技术人员仅基于现有技术的教导是否有动机改进现有技术以获得发明的技术方案，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑基于现有技术进行这种改进的可能性或者可行性。

就物质的医药用途发明而言，该物质作为已知的药物活性成分，其药理、药化等方面的研究通常较为充分，相关现有技术的信息往往汗牛充栋，在判断能否由此显而易见地得到该物质的新医药用途时，应当基于所属领域技术人员的合理认知，客观认定发明因其技术方案的选择所实现的技术效果，由此确定其实际解决的技术问题，然后对现有技术进行整体梳理，以便准确还原获得发明的过程。

1、关于本专利技术方案相应技术效果的认定

本案中，权利要求 1 保护 MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物中的用途。如前所述，本专利说明书基于 MRA 和氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的 II 期临床试验数据充分证明了，在类风湿性关节炎治疗上 MRA 与氨甲蝶呤联用具有明显优于单独治疗的疗效，且具有足够的安全性（参见本专利说明书第 0146-0177 段）。

针对前述“明显优于”的技术效果，请求人主张的理由与说明书公开不充分的无效理由完全一致。合议组认为：基于前述关于说明书是否公开充分以及权利要求能否得到说明书支持的论述，本发明公开了在临床试验的三个剂量组中组合治疗相比于 MRA 单独治疗的各项患者改善评分均有明显提升，同时在 8mg/kg 剂量组中组合治疗相比于氨甲蝶呤单独治疗的各项患者改善评分有明显提升，同时在过敏性、抗体产生、肝毒性等方面也均有改善的数据（参见本专利说明书第 0168-0175 段以及表 1），这些已经足以证明在类风湿性关节炎治疗上 MRA 与氨甲蝶呤联用具有明显优于单独治疗的疗效，且具有足够的安全性。

2、关于本专利技术方案显而易见性的判断

请求人主张：证据 3 公开了 MRA 对类风湿性关节炎的治疗作用及其有效治疗剂量，还公开了其抑制 IL-6 的安全性和功效，并可与其它类风湿性关节炎药物联用；证据 2 公开了氨甲蝶呤是类风湿性关节炎的有效治疗药物；证据 4 公开了氨甲蝶呤对类风湿性关节炎的治疗作用，并且具有 IL-6 活性、类风湿性关节炎特征性炎症过程中的细胞因子抑制作用，由此容易想到将两种药物一起用于治疗类风湿性关节炎，因此本专利权利要求 1-9 分别相对于证据 3 与证据 2 的结合、或者证据 3 与证据 4 的结合均不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

专利权人则强调：类风湿性关节炎的发病机制至今尚不明确，现有技术对于药品开发缺乏明确指引，反

证 4-6 均证明生物类病情缓解抗风湿药（DMARD）与氨甲蝶呤联合治疗的探索中存在着大量失败案例，无论是疗效还是安全性都缺乏合理的理论依据加以预期，反证 2、3、6-8 证明氨甲蝶呤与 MRA 联用的重叠肝毒性风险亦缺乏预期性。

对此，合议组认为：证据 3 公开了用 MRA 治疗类风湿性关节炎的实验方案（参见该证据的中文译文第 2 页第 10 行-第 6 页第 23 行）。将本专利权利要求 1 与证据 3 的上述技术方案相比，区别在于：权利要求 1 保护 MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物中的用途，而证据 3 仅公开了 MRA 治疗类风湿性关节炎的技术方案。基于前述本专利说明书验证的技术效果，可以确认权利要求 1 的技术方案实际解决的技术问题在于提供了一种用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物的制药用途。

就证据 3 的其它内容而言，在其实验选择的“患者群体”部分明确公开了“在使用研究药物之前，DMARD 治疗必须已经停止至少 1 个月了。……在研究药物给药前 4 周内不允许使用胃肠外和/或关节内类固醇、免疫抑制剂、研究性药物和口服抗凝血药物”（参见该证据中文译文第 2 页第 3 段），即明确排除了包括氨甲蝶呤在内的其它 DMARDs 药物对于该实验中研究 MRA 疗效和安全性的影响；在文章最后的“讨论”部分明确提到，“RA（注：即类风湿性关节炎，下同）可以被认为是一种时刻由细胞因子网络中的几种细胞因子的协同和/或叠加作用来维持的疾病。……更多地了解 RA 中的细胞因子网络可能有助于我们开发合理的组合疗法，这可能比阻断单一细胞因子更有效”（参见该证据中文译文第 5 页第 5 段），即提到可能的组合疗法来自针对多种细胞因子的组合疗法，而非 MRA 与氨甲蝶呤的组合。

就证据 2 而言，该证据属于外文科技文献，发表于本专利优先权日的 15 年前，公开了采用氨甲蝶呤单药治疗类风湿性关节炎的早期研究进展（参见该证据中文译文第 1 页第 4 段-第 4 页第 4 段），其中明确公开“尚无明确的真正长期的前瞻性有效问题的研究”（参见该证据中文译文第 1 页第 1 段），完全没有涉及组合疗法的信息，更未公开 MRA 与氨甲蝶呤组合的教导。

就证据 4 而言，该证据属于外文科技文献，发表于本专利优先权日的 13 年前，亦公开了采用氨甲蝶呤单药治疗类风湿性关节炎的早期研究进展（参见该证据中文译文第 1 页第 1 段-第 2 页第 5 段），其中提到“氨甲蝶呤在体外能抑制 IL-1 的活性，可能在氨甲蝶呤对类风湿性关节炎的快速消炎作用中发挥了重要作用”（参见该证据中文译文第 1 页第 1 段），还明确公开了“MTX（即氨甲蝶呤）似乎可以抑制一些与 RA 炎症和破坏性活动相关的细胞因子的作用，其机制尚不完全清楚”（参见该证据中文译文第 2 页第 5 段），完全没有涉及组合疗法的信息，更未公开 MRA 与氨甲蝶呤组合的教导。

就本领域的整体现有技术分析可知，类风湿性关节炎属于自身免疫性疾病，确切的病因和具体的发病机制比较复杂，尚未完全明确；治疗类风湿性关节炎的药物通常有四类，即（1）非甾体类抗炎药（NSAIDs），用于缓解类风湿性关节炎疼痛，并且减轻炎症、肿胀和发热；（2）类固醇，可降低导致类风湿性关节炎关节肿胀、僵硬和疼痛的炎症水平；（3）传统的“缓解疾病的抗风湿药”（DMARDs），通常是合成的小分子化合物，例如氨甲蝶呤等；（4）生物类“缓解疾病的抗风湿药”（DMARDs），例如托珠单抗（MRA）等。其中，前两种类型药物

与后两种药物在疗效上存在较大差异，后两种可以减缓疾病进展，但是通常会出现不良事件或药物失效。治疗类风湿性关节炎需要兼顾疗效和安全性，而 MRA 和氨甲蝶呤同属于 DMARDs，均具有肝毒性，导致其药物联用风险较高，参见例如反证 4-6。可见，针对类风湿性关节炎患者并非用药种类越多，疗效就越好，药物之间的相互作用有可能影响药效，同时联合用药还可能导致药物中毒等安全性问题，在没有充分依据和临床数据支持的前提下，本领域技术人员通常不会贸然尝试 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎，断言容易预期其联用疗效的做法难免有事后之明的嫌疑。

反证 4-6 均为本专利优先权日之前公开的期刊文献，通过对比实验均得出了类风湿性关节炎组合疗法在疗效上相对于单药疗法并未表现出优势（分别参见反证 4 中文译文第 1 页最后两段，反证 5 中文译文第 1 页倒数第 4 段、第 3 页倒数第 3 段，反证 6 中文译文第 1 页倒数第 3 段、第 2 页倒数第 2 段），反证 2 和 3 表明氨甲蝶呤随着剂量增加而毒性增加，反证 2、6、8 中还提到了氨甲蝶呤与其它药物联用时存在增加肝毒性的风险（分别参见反证 2 中文译文第 1 页最后一段，反证 6 中文译文第 1 页倒数第 2 段、第 2 页倒数第 1 段、第 4 页倒数第 1 段及原文的表 3、4，反证 8 中文译文第 2 页第 8-16 行），在安全性方面相对于单药疗法可能具有劣势，以上反证均佐证了不应当将联合用药的方案看作是已知药物的简单加和，本领域技术人员从证据 3 出发，基于常规技术知识难以合理预期到 MRA 与氨甲蝶呤联用可以有效治疗类风湿性关节炎的结论。

综上所述，本专利权利要求 1-9 分别相对于证据 3 与证据 2 的结合以及证据 3 与证据 4 的结合均具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

请求人还主张：证据 1 给出了 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的技术启示；证据 2 公开了氨甲蝶呤是类风湿性关节炎的有效治疗药物，因此本专利权利要求 1-9 分别相对于证据 1 与公知常识的结合、证据 1、2 与公知常识的结合均不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

对此，合议组认为：如前所述，证据 1 公开的“目前在几个欧洲国家正在进行一项与甲氨蝶呤联合用药的 II 期研究”信息只是在该证据公开的 MRA 单独用于治疗类风湿性关节炎的临床试验研究基础上补充的客观事实，并未公开上述 II 期临床研究的结论及数据，本领域技术人员无法认识到该证据推荐 MRA 与氨甲蝶呤联合治疗类风湿性关节炎，无法获得这样的组合能够有效联合治疗类风湿性关节炎患者的确切结论，这是本专利权利要求 1 保护的方案与该证据公开的技术方案之间的区别技术特征。基于前述本专利技术效果的分析，可知在类风湿性关节炎治疗上 MRA 与氨甲蝶呤联用具有明显优于单独治疗的疗效，且具有足够的安全性，而最接近的现有技术——证据 1 中仅提供了联合用药的研究信息，不涉及疗效和安全性信息，由此确定权利要求 1 保护的方案所实际解决的技术问题在于提供了一种具备确切的优良疗效和足够安全性的药物组合物的制药用途。

就证据 1 的其它内容而言，如前所述，该证据并未公开或者暗示 MRA 与氨甲蝶呤联合治疗类风湿性关节炎的有效性和安全性的任何信息，相反，该证据有意识地对比了现有技术中常用于治疗类风湿性关节炎的英

夫利西单抗和 MRA 相比在联合用药安全性上的不同考虑，指出“在用英夫利西单抗治疗时，需要联合使用甲氨蝶呤……然而，MRA 并不要求联合使用甲氨蝶呤”，即明示从用药安全性的角度来看，MRA 与氨甲蝶呤的联用不是必须的；最后还明确了联合用药属于下一步的研究方向，即“今后……需要对分别使用或者联用各种抗细胞因子疗法的治疗效果进行研讨”（参见该证据中文译文第 3 页第 3-24 行），这些信息都不足以提供 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎的明确教导以及合理成功预期。

如前所述，证据 2 公开了采用氨甲蝶呤单药治疗类风湿性关节炎的早期研究进展（参见该证据中文译文第 1 页第 4 段-第 4 页第 4 段），其中明确公开“还尚无明确的真正长期的前瞻性有效问题的研究”（参见该证据中文译文第 1 页第 1 段），完全没有涉及组合疗法的信息，更未公开 MRA 与氨甲蝶呤组合的教导。就本领域的整体现有技术分析可知，针对类风湿性关节炎患者并非用药种类越多，疗效就越好，药物之间的相互作用有可能影响药效，同时联合用药还可能导致药物中毒等安全性问题，在没有充分依据和临床数据支持的前提下，本领域技术人员通常不会贸然尝试 MRA 与氨甲蝶呤联用治疗类风湿性关节炎，断言容易预期其联用疗效的做法难免有事后之明的嫌疑。反证 4-6 均佐证了不应当将联合用药的方案看作是已知药物的简单加和，本领域技术人员从证据 1 出发，基于常规技术知识难以合理预期到 MRA 与氨甲蝶呤联用可以有效治疗类风湿性关节炎的结论。

综上所述，本专利权利要求 1-9 分别相对于证据 1 与公知常识的结合、或者证据 1、证据 2 与公知常识的结合均具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

（七）关于权利要求书是否简要、权利要求是否属于重复授权

专利法实施细则第 20 条第 1 款规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

“权利要求应当简要”包括两方面要求，一是权利要求应当采用构成发明技术方案的技术特征来限定其保护范围，二是从权利要求书的整体撰写要求来看，权利要求的数量应当适当。

医药用途权利要求在保护范围解读以及简要的要求上有其特殊性，仅体现于用药行为中的特征不是医药用途的技术特征，对权利要求保护的制药方法本身不具有限定作用；同时，这样的用药特征在药品专利侵权评判以及药品专利纠纷早期解决机制中专专利权保护范围的解释中可能需要有所考虑，故在专利确权程序中尚不宜仅依据“权利要求应当清楚、简要”的规定将采用用药特征限定的权利要求宣告无效。

本案中，请求人主张，从属权利要求 2-9 的附加技术特征均属于用药特征，对于权利要求 1 保护的制药用途不具备限定作用，导致以上权利要求的保护范围不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款关于权利要求书应当清楚的规定。

对此，合议组认为：就医药用途权利要求而言，在权利要求保护范围的解读以及关于权利要求应当清楚、

简要的要求上有其特殊性，体现在：一方面，如前所述，仅体现于用药行为中的特征不是医药用途的技术特征，对权利要求保护的制药方法本身不具有限定作用；另一方面，这样的用药特征在药品专利侵权评判以及药品专利纠纷早期解决机制中专专利权保护范围的解释中可能需要有所考虑，本案口头审理中双方当事人对此也表示了一定的理解认同，从这个角度上考量，已经授予专利权的从属权利要求 2-9 之附加技术特征有其存在的意义，在专利确权程序中尚不宜仅依据“权利要求应当清楚、简要”的规定将专利权整体宣告无效。

另外，请求人还主张权利要求 2-4 中的“显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量”表述不清楚，专利权人就此在口头审理当庭提交了权利要求书的修改文本，删除了权利要求 2-4 中的“或显示出与其等等的血液 MRA 浓度的剂量”这一并列技术方案，从而克服了上述缺陷。

专利法实施细则第 13 条第 1 款规定，同样的发明创造只能被授予一项专利。

同样的发明创造是指两件或者两件以上专利或者专利申请中存在保护范围相同的权利要求，如果一份专利的一项权利要求与另一件专利的权利要求的保护范围不同，则应当认为它们不属于同样的发明创造。

立法法第 93 条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。专利法和专利法实施细则关于本案涉及的“禁止重复授权”情形之规定没有变化，现行的 2010 版《专利审查指南》对于落实专利法和专利法实施细则规定作出了更合理、更有利于保护发明创造的程序性规定。综上，本案适用于 2010 版《专利审查指南》中关于“无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理”之规定，即任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法或者专利法实施细则有关禁止重复授权的规定而请求国家知识产权局宣告其中授权在前的专利权无效的，在其他无效理由不成立的情况下，国家知识产权局应当维持该项专利权有效。

鉴于前述无效理由均不成立，因此应当在前述权利要求书修改文本的基础上，维持本发明专利权有效。

即使考量本专利与其分案是否存在同样的发明创造，亦可以得出相同的结论，理由如下：

本案中，请求人主张，因为用药特征对于权利要求保护的制药用途不具备限定作用，导致本专利权利要求 1-9 与本专利的分案授权专利（ZL201511004468.9）权利要求 7 的保护范围均相同，因此本专利权利要求 1-9 属于重复授权。

对此，合议组认为：本案中，在无效宣告程序中修改后的权利要求 1 保护 MRA 和氨甲蝶呤在制备用于治疗类风湿性关节炎的药物组合物中的用途；根据第 560488 号无效宣告请求审查决定，在专利权人于 2022 年 07 月 25 日提交的权利要求第 1-5 项的基础上，维持第 201511004468.9 号发明专利权有效，其中的权利要求 1 来源于授权公告文本的权利要求 7 和 12，该权利要求保护“重组人源化的抗人白介素 6 受体单克隆抗体 MRA 和氨甲蝶呤 MTX 用于制备治疗类风湿性关节炎的 MRA 和 MTX 的组合的用途，其中所述 MRA 以 8mg/kg 的剂量通

过静脉注射 1 次/4 周给药；所述 MTX 以 10~25mg/个体/周的剂量通过口服给药；且所述组合达到的美国风湿病学会 (ACR) 50% (ACR 50) 和 70% (ACR 70) 改善率高于单独用 MTX 达到的 ACR 50 和 ACR 70 改善率。”

基于本领域的技术常识，单克隆抗体 MRA 作为抗体药物，给药方式通常为静脉注射，也可能采用皮下注射和肌肉注射等其他血管外给药方式；氨甲蝶呤作为抗代谢细胞毒素类的化学药物，一般是采用口服或者静脉点滴，或者肌内注射的方式给药的。对此，如前所述，在口头审理中专利权人亦确认 MRA 通常通过静脉输注及皮下注射给药，而氨甲蝶呤通常通过口服给药，同时也不排除肌内注射和皮下注射等常规给药方式。可见，本专利权利要求 1 保护的制药用途中氨甲蝶呤可采用口服剂型与注射剂型的形式，而分案专利权利要求 1 明确限定了所保护的制药用途中氨甲蝶呤采用口服剂型。本领域公知，口服剂型与注射剂型在药品辅料选择、制备工艺等方面均存在明显差异，由此本专利权利要求 1 与授权专利 ZL201511004468.9 维持有效的权利要求 1（来源于授权公告文本的权利要求 7 和 12）的保护范围不同，同理权利要求 2-9 与该授权专利维持有效的权利要求 1 的保护范围也均不同，即本专利与该授权专利之间不存在保护范围相同的权利要求，符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

综上，无效请求人所主张的上述无效理由均不足以导致本专利不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款和第 20 条第 1 款的规定，合议组对上述无效理由不予支持。

鉴于请求人的所有无效理由均不成立，合议组作出如下决定。

三、决定

在专利权人于 2022 年 07 月 25 日提交的权利要求第 1-9 项的基础上，维持第 200480011401.1 号发明专利权有效（具体修改文本参见书面意见）。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：王亦然

主审员：魏聪

参审员：吴文英

专利局复审和无效审理部